

Figura 2 — Oito genes. Oito decisões clínicas diferentes.

Quando o teste genético muda o plano — e quando apenas adiciona ansiedade.

1. SUPLEMENTAÇÃO E METABOLISMO

1

MTHFR

(C677T, A1298C)

Suplementar com folato metilado.

Monitorar homocisteína.

2

FADS1/2

(rs174576)

Conversão ALA → EPA/DHA reduzida.

Linhaça não resolve.

3

VDR FokI

(rs2228570)

Menor responsividade à vitamina D.

Dose maior (3.000–10.000 UI/dia em adultos comuns) 40 ng/mL.

2. COMPORTAMENTO E ESTILO DE VIDA

4

CYP1A2

(rs762551)

Metabolizador lento de cafeína.

Lento (CC): risco hipertensão e IAM. Rápido (AA): risco menor.

5

FTO

(rs9939609)

Maior tendência ao ganho.

Exercício de moderada–alta intensidade responde acima da média. (Frayling 2007)

6

ALDH2

(rs671)

Risco câncer com qualquer dose de álcool.

Abstinência ou minimização, não "moderação". (Aging Cancer 2024)

3. DECISÃO CLÍNICA ESTRATÉGICA

7

APOE4

Risco aumentado Alzheimer tardio.

Prevenção multidomínio (FINGER). Benefício maior em risco intermediário.

8

ESR1 / COL1A1

Maior perda óssea pós-menopausa.

Pesa no cálculo de TRH em mulheres em conjunto com história familiar de osteoporose.

Categorias indicam quando o resultado é acionável:

1. Suplementação e metabolismo · 2. Comportamento e estilo de vida · 3. Decisão clínica estratégica.

Fontes: variantes de impacto clínico estabelecido referenciadas em: MTHFR (Frosst 1995), APOE (Farrer, Nature Medicine 2024), FTO (Frayling 2007), ALDH2 (Brooks 2009), CYP1A2 (Cornelis 2006). Síntese do Capítulo 11.